TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 8 Bệnh tay chân miệng

Tóm tắt từ tài liệu Bệnh tay chân miệng.pdf (12 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. TÁC NHÂN VÀ DỊCH TỄ
2. SINH BỆNH HỌC
3. LÂM SÀNG
4. CẬN LÂM SÀNG
5. CHẨN ĐOÁN
6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG
7. ĐIỀU TRỊ
8. XUẤT VIỆN VÀ PHÒNG BỆNH

1. TÁC NHÂN VÀ DỊCH TỄ

- Bệnh truyền nhiễm **lây từ người sang người, dễ thành dịch**, do virus đường ruột: thường gặp **Coxsackievirus A16 (CA16)** và **Enterovirus 71 (EV71)** (họ Picornaviridae, chi Enterovirus). CA6, CA10, CA12 ít gặp hơn; **CA6** gây thể không điển hình ở châu Âu, Đông Á, Bắc Mỹ.
- **Biến chứng nặng thường do EV71:** viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, tử vong.
- **Lây chủ yếu qua đường tiêu hóa**; nguồn lây từ **nước bọt, phỏng nước, phân**. Virus tồn tại ở **hầu họng 1–3 tuần**, **trong phân 7–10 tuần**, có thể lây khi không triệu chứng.
- Gặp quanh năm; phía Nam tăng **tháng 3–5** và **tháng 9–12**. Thường ở **trẻ dưới 5 tuổi, nhất là dưới 3 tuổi**; yếu tố nguy cơ: nhà trẻ, mẫu giáo, nơi vui chơi tập trung.
- Việt Nam: báo cáo đầu tiên về EV71 năm **2003**; năm 2018 hơn 53.000 ca nhập viện. Virion khoảng 30 nm; **VP1** là đích phát triển vaccine và phân loại phân tử.

2. SINH BỆNH HỌC

- Virus nhân lên ở **mô lympho hầu họng và ruột**, giải phóng rất nhanh (5–10 giờ) → **nhiễm virus máu** → thần kinh trung ương, cơ tim, gan, da. Virus lan trong thần kinh **ngược theo dây thần kinh vận động**.
- EV71 gây viêm vùng **hạ đồi, thân não, tủy sống, nhân răng tiểu não**; cytokine (IL-6, IL-10, IL-13, IL-1β, IL-8, MCP-1) gây viêm thân não, biến chứng hô hấp – tuần hoàn → cơ sở dùng **IVIG** (trung hòa virus và cytokine).

3. LÂM SÀNG

- **Ủ bệnh 3–7 ngày. Khởi phát 1–2 ngày:** sốt nhẹ, mệt, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy.
- **Toàn phát 3–10 ngày:**
  - **Loét miệng:** sau sốt 1–2 ngày; hồng ban → **mụn nước 2–4 mm** → loét đau, **chảy nước miếng**, ăn kém; ở **phần sau khoang miệng**, nếp hầu họng, lưỡi gà, trụ trước amidan, **khẩu cái mềm**, đôi khi má, lưỡi; có thể kéo dài hàng tuần.
  - **Phát ban sẩn mụn nước: lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông**; 2–10 mm, **không đau, không ngứa, không loét**, tự hết trong khoảng 1 tuần, để lại vết thâm. CA16 mụn nước lớn hơn EV71.
  - **Sốt nhẹ 2–4 ngày**; EV71 hay **sốt cao > 39°C, kéo dài > 3 ngày**. Nôn, tiêu chảy.
  - **Sốt cao, nôn nhiều** → nguy cơ biến chứng. Biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện **ngày 2–5**.
- **Lui bệnh 3–5 ngày**, hồi phục hoàn toàn nếu không biến chứng.
- **Thể lâm sàng: tối cấp** (tử vong trong 48 giờ), cấp tính, **không điển hình** (chỉ loét miệng, hoặc biến chứng mà không ban, không loét).

4. CẬN LÂM SÀNG

- Bạch cầu thường bình thường; **bạch cầu > 16.000/mm³** hoặc **đường huyết > 160 mg%** (8,9 mmol/L) liên quan biến chứng. CRP thường < 10 mg/L.
- **Troponin I, siêu âm tim** khi **mạch ≥ 150 lần/phút**, nghi viêm cơ tim hoặc sốc; khí máu khi suy hô hấp; chọc dò tủy sống khi có biến chứng thần kinh.
- **RT-PCR** (hầu họng, phỏng nước, trực tràng, dịch não tủy) từ độ 2b hoặc cần phân biệt.

5. CHẨN ĐOÁN

- **Ca lâm sàng:** dịch tễ (tuổi, mùa, vùng, nhiều trẻ cùng mắc) + **phỏng nước điển hình ở miệng, lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông**. **Xác định:** RT-PCR hoặc phân lập virus.
- **Phân biệt loét miệng: viêm loét áp-tơ** (loét sâu, có dịch tiết, hay tái phát), đẹn.
- **Phân biệt phát ban:** sốt phát ban (hạch sau tai), dị ứng (**ngứa**), viêm da mủ, **thủy đậu** (phỏng nước nhiều lứa tuổi, rải rác toàn thân), não mô cầu (xuất huyết hoại tử), sốt xuất huyết.
- **Biến chứng thần kinh: giật mình** (dấu chỉ điểm sớm viêm thân não, thường do EV71), **rung giật cơ** 1–2 giây còn ý thức, ngủ gà, đi loạng choạng, run chi, mắt nhìn ngược, **liệt mềm cấp**, liệt dây sọ, co giật, hôn mê.
- **Biến chứng tim mạch – hô hấp** (2–5 ngày sau sốt): mạch > 150 lần/phút, CRT > 3 giây, da nổi vân tím, vã mồ hôi, chi lạnh; **huyết áp tăng giai đoạn đầu** rồi tụt; thở bất thường; **phù phổi cấp** (sùi bọt hồng).

6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG

Độ	Tiêu chuẩn chính
1	Chỉ **loét miệng và/hoặc tổn thương da**
2a	Giật mình **< 2 lần/30 phút** (bệnh sử, không thấy lúc khám); lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ; **sốt > 2 ngày** hoặc **≥ 39°C**; nôn nhiều
2b nhóm 1	**Giật mình ghi nhận lúc khám**; hoặc bệnh sử giật mình **≥ 2 lần/30 phút** kèm ngủ gà hoặc **mạch > 130** lần/phút
2b nhóm 2	**Sốt ≥ 39,5°C** không đáp ứng hạ sốt; **thất điều**; rung giật nhãn cầu, lé; yếu chi, liệt mềm; liệt dây sọ (nuốt sặc, đổi giọng); **mạch > 150** lần/phút
3	**Mạch > 170** lần/phút (hoặc mạch chậm); vã mồ hôi, lạnh; **tăng huyết áp** (< 1 tuổi > 100, 1–2 tuổi > 110, > 2 tuổi > 115 mmHg); thở bất thường; **Glasgow < 10**; tăng trương lực cơ
4	**Ngừng thở**, thở nấc; **tím, SpO_2 < 92%**; **phù phổi cấp**; **sốc** (mạch, huyết áp không đo được; tâm thu < 70 mmHg ở < 12 tháng, < 80 mmHg ở > 12 tháng; hiệu áp ≤ 25 mmHg)

7. ĐIỀU TRỊ

- **Nguyên tắc: chưa có thuốc đặc hiệu**, điều trị hỗ trợ; **không dùng kháng sinh khi không bội nhiễm**; theo dõi sát, phân độ đúng; ca nặng hồi sức ABC; đảm bảo dinh dưỡng.
- **Độ 1 – ngoại trú:** dinh dưỡng đủ, tiếp tục bú mẹ; **paracetamol 10 mg/kg/lần uống** (15 mg/kg/lần tọa dược) **mỗi 6 giờ**; **vệ sinh răng miệng**; nghỉ ngơi. **Tái khám mỗi 1–2 ngày trong 8–10 ngày đầu**; có sốt tái khám mỗi ngày đến khi **hết sốt ít nhất 48 giờ**. Tái khám ngay khi sốt ≥ 39°C, khó thở, giật mình, lừ đừ, nôn nhiều, loạng choạng, vân tím, co giật.
- **Độ 2a:** như độ 1; sốt cao không đáp ứng paracetamol phối hợp **ibuprofen 5–10 mg/kg/lần mỗi 6–8 giờ** (xen kẽ, **tối đa 40 mg/kg/ngày**), **không dùng aspirin**; **phenobarbital 5–7 mg/kg/ngày uống**.

- **Độ 2b – cấp cứu:** nằm **đầu cao 30°**, **oxy 3–6 lít/phút**, hạ sốt tích cực; **phenobarbital 10–20 mg/kg tĩnh mạch**; **IVIG 1 g/kg cho nhóm 2** (nhóm 1 không chỉ định, trừ khi không giảm sau 6 giờ phenobarbital). Theo dõi mỗi 1–3 giờ trong 6 giờ đầu, SpO_2 liên tục.
- **Độ 3 – hồi sức tích cực:** oxy, kém đáp ứng sau 30–60 phút thì **đặt nội khí quản sớm**; chống phù não (đầu cao, dịch 1/2–3/4 nhu cầu); phenobarbital (≤ 40 mg/kg/ngày); **IVIG 1 g/kg**; **dobutamin** khi suy tim mạch > 170 lần/phút không tăng huyết áp (5 → tối đa 20 µg/kg/phút); **milrinone** khi tăng huyết áp (0,4–0,75 µg/kg/phút, 24–72 giờ).
- **Chỉ định thở máy:** độ 4, hoặc độ 3 kèm thở bất thường, **thở > 70 lần/phút**, **mạch > 180 lần/phút**, gồng chi, hôn mê (Glasgow < 10).
- **Độ 4:** thở máy; chống sốc (dịch 5 mL/kg/15 phút nếu không phù phổi, dobutamin); **phù phổi: ngừng dịch**, dobutamin, furosemide khi quá tải; lọc máu, ECMO; IVIG khi HA trung bình ≥ 50 mmHg.

8. XUẤT VIỆN VÀ PHÒNG BỆNH

- **Xuất viện** (ca nội trú không nặng) khi đủ 4 điều kiện: **không sốt ≥ 24 giờ** (không dùng hạ sốt), **không còn dấu hiệu từ độ 2a ít nhất 48 giờ**, có điều kiện theo dõi và tái khám, di chứng (nếu có) đã ổn định. Độ 3, 4 phải ổn định cả biến chứng và di chứng.
- **Chưa có vaccin đặc hiệu**; phòng như bệnh lây qua **đường tiêu hóa**.
- **Cơ sở y tế:** cách ly theo nhóm, khẩu trang, **rửa tay trước và sau chăm sóc**, khử khuẩn bề mặt bằng **Cloramin B 2%**.
- **Cộng đồng: rửa tay bằng xà phòng** (sau thay tã, tiếp xúc phân, nước bọt), rửa đồ chơi, lau sàn Cloramin B 2%; **cách ly trẻ bệnh tại nhà, không đến trường 10–14 ngày đầu**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Bệnh tay chân miệng.pdf khi cần chi tiết.